Hạ đường huyết

Đường huyết dưới 70 mg/dL (3,9 mmol/L). Có thể run tay, vã mồ hôi, đói, hồi hộp, chóng mặt hoặc lú lẫn.

Còn tỉnh, nuốt an toàn

1. Dùng **15 g đường hấp thu nhanh**: viên glucose đủ 15 g theo nhãn, hoặc khoảng 120 mL nước ép, nước ngọt có đường.
2. Chờ **15 phút**, đo lại. Nếu vẫn dưới 70 mg/dL, làm lại bước 1.
3. Khi đã ổn, ăn bữa chính hoặc bữa phụ có chất bột đường và đạm.

> Đang uống **acarbose**: chỉ dùng viên hoặc bột glucose, không dùng đường kính (đường cát).

Bất tỉnh, co giật, khó nuốt

Không cho ăn uống, không đổ đường vào miệng. Gọi 115 ngay.
Dùng glucagon nếu đã được kê và người hỗ trợ đã được hướng dẫn.

Quy tắc trên dành cho người lớn. Trẻ em cần hướng dẫn riêng.

Khi nào cần trợ giúp?

Cấp cứu ngay (gọi 115) khi

- Lơ mơ, bất tỉnh, co giật, hoặc hạ đường huyết không cải thiện.
- Nôn nhiều, đau bụng, thở nhanh hoặc khó thở, nhất là khi đường huyết cao.

Khám sớm, không chờ lịch hẹn

Bàn chân có vết thương, sưng đỏ, phồng rộp, chảy dịch; hạ đường huyết tái diễn; đường huyết thường ngoài mục tiêu.

Chuẩn bị khi tái khám

Mang sổ đường huyết, đơn thuốc. Hỏi bác sĩ cách dùng thuốc khi bị ốm.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
Phòng Điều dưỡng
32 Phạm Ngọc Thạch, Khóm Châu Long 7, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Điện thoại: **0296 3562 357**
Cấp cứu: **115**

Nguồn: WHO. Diabetes.
CDC. Low Blood Sugar; Meal Planning; Your Feet and Diabetes; Diabetic Ketoacidosis.
Bộ Y tế. QĐ 5481/QĐ-BYT (2020); QĐ 1353/QĐ-BYT (2021). SmPC Acarbose.
TTGDSK.DTD.TB · Phiên bản 02 · Rà soát 19/10/2026
Ngày duyệt: ...../...../2026

Bệnh viện đa khoa NHẬT TÂN

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Chăm sóc mỗi ngày để phòng biến chứng

Dành cho người trưởng thành mắc đái tháo đường và người chăm sóc.

ĂN HỢP LÝ

DÙNG THUỐC ĐÚNG

THEO DÕI ĐỀU

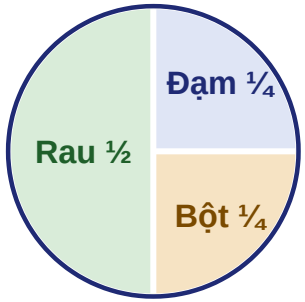
Đái tháo đường là bệnh mạn tính. Điều trị và chăm sóc đều đặn giúp giảm nguy cơ tổn thương tim, mắt, thận và bàn chân.

Kế hoạch điều trị cần phù hợp với từng người theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ăn uống hợp lý

Ăn đúng bữa, lượng vừa đủ. Hỏi nhân viên y tế để chọn khẩu phần phù hợp.

Gợi ý một đĩa ăn cân đối



- **½ đĩa:** rau ít tinh bột như rau lá, cải, dưa leo.
- **¼ đĩa:** cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ.
- **¼ đĩa:** cơm, bún, khoai hoặc thực phẩm có chất bột đường.

Chọn nước lọc; hạn chế nước ngọt, trà sữa. Ăn trái cây nguyên miếng, lượng vừa phải, hạn chế nước ép.

Không tự bỏ hoàn toàn cơm và chất bột đường. Người có bệnh thận hoặc đang mang thai cần được tư vấn riêng.

Điều trị mỗi ngày

Dùng thuốc đúng đơn

Uống thuốc, tiêm insulin đúng hướng dẫn. Không tự tăng, giảm hoặc ngừng thuốc khi thấy đường huyết ổn. Hỏi cách xử trí nếu quên liều.

Theo dõi và ghi chép

Đo đường huyết theo lịch được hướng dẫn; ghi kết quả, bữa ăn, vận động và triệu chứng bất thường. Mục tiêu đường huyết khác nhau ở từng người.

Vận động phù hợp

Vận động đều, bắt đầu nhẹ và tăng dần. Hỏi nhân viên y tế hoạt động nào an toàn, nhất là khi có bệnh tim hoặc vết loét chân.

Phòng biến chứng

Không hút thuốc. Tái khám đúng hẹn; kiểm tra mắt, thận, bàn chân, huyết áp và mỡ máu theo chỉ định.



Luôn mang theo: thông tin bệnh, danh sách thuốc, máy đo và đường hấp thu nhanh nếu có nguy cơ hạ đường huyết.

Bảo vệ bàn chân

Đái tháo đường có thể làm chân mất cảm giác. Vết thương nhỏ cũng cần được chú ý.

- **Nhìn kỹ mỗi ngày:** mu chân, lòng bàn chân, kẽ ngón; dùng gương hoặc nhờ người thân.
- Thử nước bằng khuỷu tay hoặc nhiệt kế; rửa nước ấm, không ngâm chân. Lau khô kẽ ngón.
- Dưỡng ẩm da khô, không bôi vào kẽ ngón.
- Mang giày dép vừa chân, kiểm tra bên trong trước khi mang. Không đi chân trần, kể cả trong nhà.
- Cắt móng ngang; không tự cắt chai chân hoặc dùng thuốc tẩy chai.

Có vết loét, phồng rộp, sưng đỏ hoặc chảy dịch: đi khám sớm, kể cả khi không đau.

Nhờ nhân viên y tế kiểm tra bàn chân mỗi lần tái khám.



Giày vừa chân.
Kiểm tra bên trong trước khi mang.